Клинические рекомендации

Перелом верхней челюсти

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**S02.4** — Перелом скуловой кости и верхней челюсти
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 17.01.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	ООО «Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии»
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/632_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определения 3

2.2 Этиология и эпидемиология 3

2.3 Классификация 4

2.4 Клиническая картина 4

3. Диагностика 5

3.1 Критерии диагноза 5

3.2 Жалобы и анамнез 5

3.3 Осмотр, пальпация, перкуссия 5

3.4 Анализы крови перед операцией и на этанол 5

3.5 Рентгенография и компьютерная томография 5

3.6 Консультации специалистов 6

4. Лечение 6

4.1 Обезболивание 6

4.2 Антибактериальная профилактика и терапия 6

4.3 Иммобилизация и ортопедическое лечение 6

4.4 Хирургическое лечение 7

4.5 Диетотерапия 7

4.6 Медицинская реабилитация 7

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 7

5.1 Показания к госпитализации 7

5.2 Диспансерное наблюдение 7

6. Источник и актуальность 8

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 8

1. Основные положения

- Перелом верхней челюсти — повреждение верхней челюсти с нарушением её целостности. Переломы по типу Ле Фор, как правило, сопровождаются сотрясением (ушибом) головного мозга и переломом основания черепа.
- При повреждении ЛОР-органов (гемосинус и др.) показана консультация оториноларинголога. При нарушении стенок верхнечелюстной пазухи назначают деконгестанты для уменьшения отёка слизистой оболочки пазухи и соустья.
- Для переломов характерны носовое кровотечение, иногда с назальной ликвореей, и быстро нарастающий отёк лица с кровоизлиянием в параорбитальную клетчатку.
- Рентгенография не менее чем в 2 проекциях; перед операцией — КТ. Через **6 недель** после операции — контрольная томография для подтверждения консолидации и исключения посттравматического воспаления в верхнечелюстной пазухе.
- Рентгенологически подтверждённый перелом верхней челюсти — показание к экстренной госпитализации.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Гемосинус — скопление крови в придаточных пазухах носа.

Назоликворея — ликворея в полость носа через дефект твёрдой мозговой оболочки в передней черепной ямке. Отоликворея — истечение ликвора через наружный слуховой проход через дефект твёрдой мозговой оболочки в средней черепной ямке.

Симптом «носового платка» — чистый носовой платок, смоченный ликвором, при высыхании остаётся мягким, а смоченный носовым отделяемым становится жёстким («накрахмаленным»). Проба «двойного пятна» — кровь образует на марлевой салфетке бурое пятно в центре, а по периферии — жёлтый венчик цереброспинальной жидкости.

Симптом «очков» — кровоизлияние в клетчатку век.

Симптом Малевича («разбитого горшка») — признак перелома скуловой кости, верхней челюсти: при перкуссии зубов слышен глухой дребезжащий звук, как от треснувшего глиняного горшка.

Симптом Герена — боль по ходу щели перелома при надавливании указательным пальцем на крючки крыловидных отростков клиновидной кости (снизу вверх).

Синдром повреждения верхней глазничной щели — офтальмоплегия, птоз, отсутствие чувствительности верхнего века и кожи лба, расширение и фиксированное положение зрачка.

Средняя зона лицевого черепа — зона между линией по верхним краям глазниц и линией смыкания зубов; включает кости носа, стенки глазниц, скуловые кости и дуги, верхние челюсти.

2.2 Этиология и эпидемиология

Перелом возникает от прямого удара или сдавления лицевого черепа. Ле Фор I — горизонтальная сила к альвеолярному отростку; Ле Фор II и III зависят от направления силы относительно франкфуртской горизонтали: горизонтальный удар — Ле Фор II, косой удар вниз — Ле Фор III.

Переломы верхней челюсти составляют 2–5% переломов лицевого черепа: Ле Фор I — 52–53%, Ле Фор II — 35–37%, Ле Фор III — 13–15%. Причины: дорожно-транспортная травма (63%), падение с высоты (27%), бытовая травма (10%). Повреждение органа слуха (барабанной перепонки, слуховых косточек) — 1,3%; субарахноидальное кровоизлияние — 10%.

2.3 Классификация

Классификация неогнестрельных переломов тела верхней челюсти (Le Fort, 1901)

Тип по Ле Фор	Линия перелома и признаки
I (нижний, перелом Герена)	отделение альвеолярного отростка и твёрдого нёба: от основания грушевидного отверстия через скулоальвеолярный гребень и бугор к крыловидным отросткам; смещение небольшое, возможно носовое кровотечение (повреждена слизистая оболочка дна верхнечелюстной пазухи и полости носа)
II (средний, суборбитальный, пирамидальный)	через носолобный шов, внутреннюю и нижнюю стенки глазницы к скуловерхнечелюстному шву; отрыв верхней челюсти с костями носа; носовое кровотечение, «симптом очков», отёк, нарушение прикуса
III (верхний, суббазальный, черепно-лицевое разъединение)	полное отделение лицевых костей от основания черепа, в отличие от I и II типов — с переломом скуловой кости; симптомы выражены резче

Изолированные типы Ле Фор встречаются редко; чаще сочетание типов с одной или разных сторон. Варианты Вассмунда близки к Ле Фор II и III, но кости носа остаются неподвижными.

1. **другие переломы** — сагиттальные (односторонние); переломы альвеолярного и лобного отростков, твёрдого нёба; оскольчатый перелом передней стенки верхнечелюстной пазухи; переломы с повреждением назоорбитоэтмоидального комплекса
2. **по давности** — свежие (**до 14 дней**), застарелые (14–28 дней), неправильно консолидированные (более 28 дней — кодируются как T90.2)
3. **по линии перелома** — линейные, оскольчатые
4. **по механизму** — огнестрельные (классификация Д. Е. Танфильева) и неогнестрельные

2.4 Клиническая картина

Признаки перелома

1. быстро нарастающий отёк лица, кровоизлияние в параорбитальную клетчатку (симптом «лица панды»);
2. носовое кровотечение, иногда с назальной ликвореей;
3. подкожная эмфизема и крепитация (воздух из воздухоносных путей);
4. симптом «плавающего нёба» — подвижность верхней челюсти при раскачивании;
5. симптом «ступеньки» в области скуловерхнечелюстного сочленения и скулоальвеолярного гребня;
6. нарушение прикуса, часто открытый прикус;
7. удлинение или уплощение средней зоны лица;
8. положительные симптомы Малевича и Герена.

Переломы часто сочетаются с переломами костей носа, дна глазницы и лобной пазухи, повреждением органа зрения и ЛОР-органов, черепно-мозговой травмой.

Подвижность костей носа и увеличение межкантального расстояния указывают на повреждение назоорбитоэтмоидального комплекса. При повреждении скуловых костей возможен «скуловой синдром»: снижение чувствительности и функции мимических мышц.

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз устанавливается на основании

1. анамнеза: факт травмы, носовое кровотечение;
2. жалоб: отёк, кровоподтёки, боль, носовое кровотечение, онемение кожи лица и зубов, изменение формы лица и прикуса, ограничение открывания рта;
3. физикального обследования: деформация, патологическая подвижность и крепитация отломков, подкожная эмфизема, затруднение носового дыхания, гипестезия, звук «треснувшего горшка»;
4. инструментального обследования: линии переломов и смещение фрагментов.

3.2 Жалобы и анамнез

Оценивают сознание, факт и длительность потери сознания, амнезию, головокружение, тошноту, рвоту, головную боль — для верификации черепно-мозговой травмы и консультации невролога или нейрохирурга.

Уточняют механизм, дату, время и место травмы. При противоправных действиях или ДТП сообщают в правоохранительные органы.

3.3 Осмотр, пальпация, перкуссия

Всем пациентам — визуальный осмотр, пальпация и перкуссия челюстно-лицевой области.

Определяют прикус: смещение отломков изменяет соотношение верхней и нижней зубных дуг.

Оценивают чувствительность лица: часто снижена в зоне подглазничного нерва (нижнее веко, подглазничная область, скат носа, верхняя губа, зубы на стороне травмы).

Оценивают симптом «очков».

При переломе верхней челюсти он появляется сразу и распространён; при изолированном переломе основания черепа — не ранее чем **через 12 часов** (чаще через 24–48 часов) и не выходит за пределы круговой мышцы глаза.

При подозрении на перелом основания черепа — проба «двойного пятна» или «носового платка» для выявления ликвореи; выявить её сложно из-за сопутствующего кровотечения.

Оценивают энофтальм, гипофтальм, экзофтальм, глазодвигательные нарушения, остроту зрения и диплопию — переломы стенок глазницы, ретробульбарная гематома, синдром верхней глазничной щели.

Подвижность отломков определяют, захватив альвеолярный отросток во фронтальном отделе и осторожно смещая челюсть вперёд-назад; пальцы другой руки — на области носа и нижнеглазничного края.

3.4 Анализы крови перед операцией и на этанол

Перед операцией — лабораторные исследования для исключения противопоказаний; при подозрении на алкогольную интоксикацию, ДТП или производственной травме — определение этанола в крови или моче.

3.5 Рентгенография и компьютерная томография

Всем — рентгенография не менее чем в 2 проекциях (прямая и боковая черепа, аксиальная и полуаксиальная); при планировании операции — КТ челюстно-лицевой области. Переломы без смещения на рентгенограммах выявляются трудно — при необходимости КТ или конусно-лучевая томография.

3.6 Консультации специалистов

Всем на этапе диагноза — консультация нейрохирурга или невролога для исключения черепно-мозговой травмы.

При признаках повреждения ЛОР-органов (гемосинус и др.) — консультация оториноларинголога для уточнения диагноза и тактики обследования.

При глазодвигательных нарушениях, энофтальме, гипофтальме, гифеме, анизокории, диплопии, снижении зрения — консультация офтальмолога.

---

4. Лечение

4.1 Обезболивание

Обезболивание подбирают по интенсивности боли.

1. **слабая боль** — парацетамол
2. **умеренная** — НПВП, парацетамол с кеторолаком или кетопрофеном, опиоиды в комбинации с неопиоидными анальгетиками
3. **интенсивная** — опиоиды

При черепно-мозговой травме опиоиды противопоказаны.

4.2 Антибактериальная профилактика и терапия

Всем, кому планируется операция, — периоперационная антибиотикопрофилактика: разовая терапевтическая доза внутривенно за **30–60 минут** до разреза, однократно; при продлении — отмена не позднее **24 часов** после операции. Все переломы верхней челюсти условно считаются открытыми.

1. #цефазолин 2,0–3,0 г + метронидазол 0,5–1 г, либо цефуроксим 1,5 г, либо амоксициллин + клавулановая кислота;
2. при аллергии на бета-лактамы или высоком риске MRSA — ванкомицин 15 мг/кг или #клиндамицин.

Повторная интраоперационная доза — при операции длительнее 2 периодов полувыведения препарата и при массивной кровопотере.

При инфицированной ране (старая травма, гнойное отделяемое, нежизнеспособные ткани) — антибиотикотерапия.

При нарушении целостности стенок верхнечелюстной пазухи — деконгестанты местно для уменьшения отёка слизистой оболочки пазухи и соустья, улучшения дренажа и профилактики воспаления.

4.3 Иммобилизация и ортопедическое лечение

При подозрении на перелом — транспортная иммобилизация (подбородочно-теменная повязка, пращевидная повязка) для уменьшения боли и кровотечения до решения о лечении.
Противопоказания: бессознательное состояние, тошнота, рвота (угроза асфиксии).

Ортопедический метод — попытка репозиции и иммобилизации отломков назубными шинами или внутрикостными винтами с межчелюстной резиновой тягой и подбородочной повязкой; при беззубых челюстях — шина Порта. Противопоказан при черепно-мозговой травме средней и тяжёлой степени, нестабильной гемодинамике, тошноте и рвоте.

После вмешательства оценивают восстановление прикуса и выполняют контрольную рентгенографию или КТ.

4.4 Хирургическое лечение

Показание — перелом с выраженным смещением отломков; противопоказание — крайне тяжёлое состояние. При тяжёлой сочетанной травме открытую репозицию и фиксацию выполняют после стабилизации (принцип Damage Control).

Накостный остеосинтез выполняют под общим обезболиванием; интубацию целесообразно проводить через носовые ходы, чтобы трубка не мешала восстановлению прикуса. При выраженной деформации носовых ходов — интубация через рот с выведением трубки через подподбородочный разрез или временная трахеостома.

При смещении и подвижности отломков — остеосинтез титановыми или биодеградируемыми накостными пластинами и винтами; после операции — оценка прикуса и контрольная КТ.

4.5 Диетотерапия

При нарушении сосания, жевания и глотания — первая челюстная диета (кормление через зонд); при сохранённых глотании и сосании — вторая челюстная диета (кашицеобразная пища).

4.6 Медицинская реабилитация

Всем после операции — реабилитация: первый этап **с 7-х по 10-е сутки** (стационар 3–5 дней, затем амбулаторно 10–15 дней), второй — **с 15-х по 45-е сутки**, включая профилактику посттравматического верхнечелюстного синусита и контрактуры. Межчелюстные тяги меняют не реже 1 раза в 7 дней.

При черепно-мозговой травме физиотерапия противопоказана.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Экстренная госпитализация — рентгенологически подтверждённый перелом верхней челюсти; плановой госпитализации нет: перелом является неотложным состоянием.

Показания к выписке

1. неосложнённый послеоперационный период, удовлетворительное положение отломков, отсутствие ликвореи и прогрессирующих гнойно-воспалительных процессов;
2. перевод в другое учреждение;
3. требование пациента или законного представителя;
4. несоблюдение режима, если это не угрожает жизни.

5.2 Диспансерное наблюдение

По показаниям при выписке — профилактический осмотр оториноларинголога, офтальмолога, невролога или нейрохирурга.

Всем через **6 недель** после операции — контрольная томография лицевого черепа: консолидация отломков и исключение посттравматического воспаления в верхнечелюстной пазухе.

Неблагоприятно влияют на исход

1. инфекционные осложнения;
2. несоблюдение гипотермии, гигиены полости рта, диеты и ограничения жевательной нагрузки;
3. контактные виды спорта в течение **3 месяцев**;
4. пропуск контрольных осмотров.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Перелом верхней челюсти»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 17.01.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее января 2028 года
Код в рубрикаторе	632_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Клинически значимых расхождений в тексте рекомендации при сверке не найдено.